

Assicurazione Invalidità (AI) —

Approfondimenti

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 06 · 17 aprile 2026

Questa lezione è la chiusura del capitolo sui tre pilastri, con focus sull'AI: come funziona, come si calcola il grado di invalidità, cosa succede in procedura e chi sono i familiari curanti. Per voi come futuri operatori sociali, questa è roba che incontrerete sul campo ogni settimana.

Ripasso del sistema di contribuzione

Prima di entrare nell'AI, il prof ha ripreso il quadro d'insieme delle **11 assicurazioni sociali svizzere** e come vengono finanziate.

Le fonti di finanziamento sono tre: 1. **Contributi sociali** — prelevati su salari e redditi (fonte principale) 2. **Contributi pubblici** — lo Stato interviene in misura variabile per assicurazione 3. **Prodotti del capitale** — rendimenti delle riserve investite sui mercati finanziari

I **salariati** sono affiliati obbligatoriamente a **7 assicurazioni**:

Assicurazione	Tasso approssimativo
AVS	4,35% (+ 4,35% datore di lavoro)
AI	0,7% (+ 0,7% datore)
IPG	contributo modesto
AD (disoccupazione)	contributo condiviso
PP (secondo pilastro)	obbligatorio sopra CHF 22'060/anno
AINF professionale	a carico del datore

Assicurazione	Tasso approssimativo
AINF non professionale	a carico del salariato

Le altre 4 assicurazioni non compaiono nel conteggio del salario perché finanziate diversamente: - **Prestazioni complementari e assicurazione militare** → finanziate dalla Confederazione (fiscalità) - **Assicurazione malattia obbligatoria** → pagata direttamente dal cittadino (non tramite salario) - **Prestazioni transitorie (PT)** → finanziate dallo Stato

Attenzione classica d'esame: **l'assistenza sociale NON è un'assicurazione sociale**. È una prestazione commisurata al bisogno, finanziata dai Cantoni. Non confonderle mai.

Gli indipendenti: meno tutelati

Gli **indipendenti** sono coperti solo da **AVS, AI e IPG** (assicurazioni universali). Non hanno: - Assicurazione contro la disoccupazione - Previdenza professionale obbligatoria (possono aderire facoltativamente, ma pochi lo fanno) - Assicurazione infortuni obbligatoria

Questo significa che se un indipendente si ammala e perde reddito, non ha copertura automatica. Come operatore sociale, ti verranno presentati questi casi: consiglia sempre di stipulare un'assicurazione facoltativa contro gli infortuni (spesso tramite la cassa malati).

Dato significativo: circa un terzo degli indipendenti non ha né secondo né terzo pilastro. Una condizione finanziaria spesso precaria.

L'indennità giornaliera per malattia: la lacuna del sistema

C'è un rischio che il sistema svizzero **non copre obbligatoriamente**: la perdita di guadagno per malattia banale (es. appendicite, burnout, problemi muscoloscheletrici).

- Chi ha un contratto collettivo o un datore generoso → assicurato per malattia fino a 2 anni
- Chi non ha questa copertura → il datore deve pagare il salario, ma **solo per poche settimane** (da 3 settimane per chi ha 1 anno di anzianità fino a max 6 mesi per 20 anni di servizio)

Proposte per renderla obbligatoria sono state **sempre bocciate in Parlamento**. Il prof lo sottolinea come un punto critico del sistema.

L'Assicurazione Invalidità (AI) — Panoramica

Scopo e copertura

L'**AI** è un'assicurazione **universale**: copre tutta la popolazione residente in Svizzera (non solo i salariati). Il suo scopo è garantire il fabbisogno esistenziale in caso di invalidità, tramite: - **Provvedimenti di integrazione** (aiuto a tornare al lavoro) - **Prestazioni pecuniarie** (rendite, indennità)

Organizzazione

- A livello federale si appoggia agli organi dell'AVS
- Gli **Uffici AI cantonali** applicano la LAI
- Le agenzie comunali AVS sono il primo contatto
- **Pro Infirmis** si occupa di accompagnamento e sostegno

Finanziamento

- Prelievo dell'**1,4%** su salari e redditi da lavoro indipendente

- I non attivi versano tra **CHF 70** e **CHF 3'500/anno** secondo la loro condizione economica
 - La Confederazione copre tra il **37,7%** e il **50%** delle uscite annuali
 - Base legale: **LAI** + in Ticino la **LISPI** (Legge cantonale per l'integrazione sociale e professionale degli invalidi)
-

La procedura AI: dall'inizio alla decisione

Ecco come funziona l'iter (il prof lo ha spiegato tre volte — sì, è importante):

1. Rilevamento tempestivo (entro 30 giorni)

Quando una persona che lavora manifesta problemi di salute con assenze ripetute, scatta il **rilevamento tempestivo**. L'obiettivo: intervenire subito, prima che il problema si cronicizzi.

2. Intervento tempestivo (max 12 mesi, max CHF 20'000)

L'AI finanzia una serie di interventi per mantenere la persona al lavoro: - Adeguamento del posto di lavoro (**es. ergonomia**) - Orientamento professionale - Corsi di formazione - Collocamento (sostegno nella ricerca d'impiego) - Riabilitazione socio-professionale - Provvedimenti di occupazione - Consulenza e accompagnamento

3. Decisione finale — tre possibilità

Alla fine dei **12 mesi**, l'Ufficio AI prende **una di queste tre decisioni**:

Decisione	Cosa succede
Provvedimenti di integrazione	Ulteriori misure per aiutare il ritorno al lavoro
Esame del diritto alla rendita	Si valuta il grado di invalidità
Nessuna prestazione	L'AI ha fatto il suo, l'assicurato si arrangia

Il ruolo dell'operatore sociale è cruciale in questa fase: può accompagnare la persona, supportarla nel capire le decisioni, e in certi casi intervenire sulle valutazioni.

I provvedimenti di integrazione

Se l'AI decide per i provvedimenti di integrazione, ecco cosa può offrire:

Provvedimenti sanitari (art. 12 LAI): trattamento medico per infermità congenite fino ai 20 anni. Niente franchigie.

Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI): preparazione all'integrazione professionale. Durata massima: 1 anno. Pensato per chi è lontano dal mondo del lavoro (dipendenze, lunghe assenze, ecc.).

Provvedimenti professionali (art. 15 e ss. LAI): la categoria più rilevante per gli operatori sociali: - Orientamento professionale (art. 15) - Prima formazione o perfezionamento professionale (art. 16) - Riformazione professionale (art. 17) - Collocamento (art. 18) - Lavoro a titolo di prova (art. 18a) - Assegno per il periodo di introduzione al datore di lavoro (art. 18b) - Indennità per compensare l'aumento dei contributi al datore (art. 18c) - Aiuto in capitale per avvio di lavoro autonomo (art. 18d)

Mezzi ausiliari: attrezzature e dispositivi per favorire autonomia e mobilità (sedie a rotelle, ecc.).

Indennità giornaliera: chi è in procedura non lavora (è in formazione, riformazione...) e deve comunque vivere. L'AI versa un'indennità giornaliera per coprire spese quotidiane durante i provvedimenti professionali.

Il grado di invalidità e la rendita

Questa è la parte più importante — e più controintuitiva — di tutta la lezione.

Definizione economica (non medica)

Il grado di invalidità **non dipende dallo stato fisico o mentale** della persona. Dipende da una valutazione **economica**: il confronto tra quanto guadagnava prima e quanto potrebbe ragionevolmente guadagnare dopo.

Immagina una pianta che viene tagliata al tronco: il grado di invalidità non misura quanto è stata danneggiata, ma quanto è ridotta la sua capacità di produrre frutti. Stesso principio.

"Sono su una sedia a rotelle, ma come è possibile avere solo il 45%?" — È possibilissimo, perché il criterio è economico, non medico.

Formula del calcolo

Grado di invalidità = (Perdita di guadagno / Reddito senza invalidità)

Esempio pratico (dal prof): - Reddito senza invalidità: CHF 60'000 - Reddito d'invalido (quello che potrebbe ragionevolmente ottenere): CHF 20'000 - Perdita di guadagno: CHF 40'000 - Grado di invalidità: $40'000 / 60'000 \times 100 = 67\%$ - Rendita AI corrispondente: circa il 67% di una rendita intera

Soglie per la rendita (dal 1° gennaio 2022, sistema lineare)

Grado di invalidità	Rendita
< 40%	Nessuna rendita AI
40–49%	Quota proporzionale secondo tabella graduata (vedi sotto)
50–69%	Rendita = % corrispondente al grado (es. 55% → 55% di una rendita intera)
≥ 70%	Rendita intera

Per il grado 40–49%, la quota non è lineare ma segue una tabella specifica — utile saperlo per l'esame:

Grado	Quota rendita	Grado	Quota rendita
40%	25%	45%	37,5%
41%	27,5%	46%	40%
42%	30%	47%	42,5%
43%	32,5%	48%	45%
44%	35%	49%	47,5%

La rendita intera varia tra **CHF 1'260 e CHF 2'520 al mese** (scala 44, dal 1° gennaio 2025), in base al reddito medio determinante.

Esempio numerico: - Reddito determinante: CHF 21'168, grado invalidità 55% -
Rendita: $55\% \times \text{CHF } 1'391 = \text{CHF } 765/\text{mese}$

Un sistema meritocratico-occupazionale

Il prof sottolinea un punto critico: chi guadagnava di più prima dell'invalidità riceve una rendita più alta. Il sistema è costruito attorno al **reddito acquisito sul mercato del lavoro**. Chi non lavorava (es. persone senza attività lucrativa) viene valutato sulla base della capacità di svolgere attività domestiche.

Potenziale tema d'esame: spiegare perché il sistema AI può essere definito "meritocratico-occupazionale".

L'interesse dell'Ufficio AI

C'è un problema strutturale: l'Ufficio AI ha interesse a riconoscere meno rendite possibile. Chi si trova con un grado valutato al 39% (appena sotto la soglia del 40%) non ha diritto alla rendita AI ordinaria, ma potrebbe avere una rendita: - Dal **secondo pilastro** (previdenza professionale): inizia già al 40% o meno - Dall'**assicurazione infortuni**: parte già dal 10%

Casi particolari

Persone senza attività lucrativa: il grado di invalidità si calcola con un "confronto delle attività" — valutazione di quanto l'invalidità incide nelle attività domestiche quotidiane. Per chi ha un'occupazione parziale, il calcolo tiene conto di entrambi i settori: perdita di guadagno + confronto delle attività domestiche. **Qui è importante la presenza di operatori sociali durante la valutazione.**

Invalidi precoci (prima dei 23 anni): se non hanno accumulato 3 anni di contributi, hanno diritto a una **rendita straordinaria** di **CHF 1'680/mese**. Possono cumularla con rendite per figli.

Invalidi precoci (prima dei 25 anni) con contribuzione completa: chi è diventato invalido prima dei 25 anni e ha una durata completa di contribuzione ha diritto a una rendita AI pari almeno al 133 $\frac{1}{3}$ % dell'importo minimo della rendita completa.

Chi riceve la rendita AI in Svizzera

Più di 220'000 persone beneficiano di una rendita AI in Svizzera. Di queste, oltre **100'000 per cause psichiche** — un numero in crescita, soprattutto nelle fasce giovani. Le malattie psichiche (burnout, depressione, disturbi d'ansia) sono diventate la prima causa di invalidità.

Per voi come operatori sociali: sempre più giovani entrano in procedura AI prima dei 25 anni. Conoscere le rendite straordinarie e i provvedimenti di integrazione precoce è fondamentale.

Possibilità di ricorso: qualsiasi decisione dell'AI può essere impugnata davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali. Il ricorso può riguardare: ammontare della rendita, riconoscimento di una malattia psichica come causa d'invalidità, diniego di prestazioni di integrazione. **Ma il percorso è lungo, costoso e non garantisce esito positivo.**

Il contributo per l'assistenza

Quando una persona ha perso quasi tutta l'autonomia, l'AI può versare un **contributo per l'assistenza** per pagare una terza persona (non un familiare stretto) che la accudisce a domicilio.

- Importo standard: **CHF 35.30/ora** (dal 1° gennaio 2023)
- Con qualifiche particolari: **CHF 52.95/ora**
- Servizio notturno: max **CHF 169.10/notte**

La logica non è la generosità: **mantenere la persona a domicilio costa meno che in istituto**. È un provvedimento sussidiario — si attiva solo esauriti gli altri sostegni.

Fin qui la parte core dell'AI. Adesso un secondo blocco altrettanto importante per la pratica: i familiari curanti.

I familiari curanti — Documento DSS Ticino

Il secondo documento della lezione è l'opuscolo del **DSS** (Dipartimento della Sanità e Socialità) del Canton Ticino sui familiari curanti.

Chi sono

Il **familiare curante** è chi presta regolarmente assistenza, sorveglianza e accompagnamento, a titolo non professionale, a una persona dipendente da terzi.

Cifre per il Ticino: - Oltre **50'000 persone** prestano assistenza almeno una volta a settimana - Il **55,3%** sono donne, **44,7%** uomini - Il **62,9%** ha un'occupazione professionale (41,4% a tempo pieno, 21,5% a tempo parziale) - Il **72,5%** è impegnato più volte a settimana

Cosa fanno

Attività	% dei familiari curanti
Vita quotidiana (economia domestica, trasporti)	88%
Coordinamento e pianificazione assistenza	85%
Questioni finanziarie e amministrative	80%
Sorveglianza	67%
Aiuto infermieristico / medicinali	55%
Cura e assistenza diretta	55%

Rischio di sovraccarico (caregiver burden)

Prendersi cura di qualcuno è arricchente, ma comporta rischi reali. Il **caregiver burden** si manifesta con: - Isolamento sociale - Ansia e disturbi del sonno - Senso di colpa - Stanchezza fisica e psichica

Strategie per prevenirlo: identificare i propri limiti, chiedere aiuto alla rete sociale, ritagliarsi tempo per sé.

Contributi finanziari per i familiari curanti

Congedo di assistenza (art. 329h CO): - Max 3 giorni per evento, max 10 giorni/anno - Per assistere un familiare malato, infortunato o invalido - Richiede certificato medico

Indennità di assistenza (IPG): - Per genitori che devono assentarsi dal lavoro per un figlio minorenne con gravi problemi di salute - Max 98 giorni (entro 18 mesi) - **Importante: NON confondere con il contributo per l'assistenza dell'AI — sono dispositivi diversi**

Accrediti per compiti assistenziali: - Supplemento al reddito usato per calcolare la rendita AVS futura - **Permette ai familiari curanti di ricevere una rendita**

più alta - Condizione: la persona assistita deve percepire un AGI (Assegno per grandi invalidi)

Rete di servizi in Ticino

L'opuscolo descrive una rete articolata: - **SACD** (Servizi di assistenza e cura a domicilio): ABAD, ALVAD, SCuDo, Spitex Tre Valli, ecc. - **Centri diurni socio-assistenziali (CDSA)**: per persone anziane o con disabilità leggera - **Centri diurni terapeutici (CDT)**: per patologie dementigene e ridotta autonomia - **Soggiorni temporanei**: per sgravare il familiare curante (fino a 30 giorni/anno per persone con disabilità) - **Collaboratori familiari (badanti)**: con supporto dell'Antenna Badanti presso ogni SACD - **Servizio telesoccorso (ATTE)**: dispositivo indossabile collegato al 144 - **Pro Infirmis, Pro Senectute, Croce Rossa**: consulenza, trasporti, sostegno famiglie

Domande di orientamento allo studio

Perché il grado di invalidità è una definizione economica e non medica?

Fai un esempio. Il grado di invalidità misura la perdita di capacità di guadagno, non lo stato fisico o psichico. Si calcola confrontando il reddito ipotetico che la persona avrebbe senza invalidità con il reddito effettivo che potrebbe ragionevolmente ottenere con la sua condizione attuale. **Esempio: una persona su sedia a rotelle che svolgeva lavoro impiegatizio con reddito di CHF 60.000 e che potrebbe continuare a lavorare in ufficio con reddito di CHF 40.000 avrà un grado di invalidità del 33% (inferiore alla soglia del 40%) e non avrà diritto a rendita AI. Il danno fisico esiste, ma la capacità di guadagno non è sufficientemente ridotta.**

Come si calcola il grado di invalidità e quali sono le soglie per la rendita AI?

Formula: $\text{grado di invalidità} = (\text{perdita di guadagno} / \text{reddito senza invalidità}) \times 100$. **Esempio: reddito senza invalidità CHF 60.000, reddito d'invalido CHF 20.000 → perdita CHF 40.000 → grado 67%.** Le soglie: **sotto il 40% nessuna rendita**; tra 40-49% rendita proporzionale graduale; tra 50-69% rendita proporzionale al grado (es. 55% → 55% della rendita intera); dal 70% in su rendita intera. La rendita intera varia da **CHF 1.260 a CHF 2.520** al mese.

Quali sono le tre fasi della procedura AI dall'inizio alla decisione? Le tre fasi sono: (1) **rilevamento tempestivo** entro 30 giorni dall'insorgenza del problema di salute sul lavoro — scatta prima che la situazione si cronicizzi; (2) **intervento tempestivo**, durata massima 12 mesi e spesa massima CHF 20.000, con misure pratiche come adeguamento del posto di lavoro, orientamento professionale, riabilitazione socio-professionale; (3) decisione finale con tre possibili esiti: ulteriori provvedimenti di integrazione, esame del diritto alla rendita, o nessuna prestazione.

Cos'è il contributo per l'assistenza AI e come si differenzia

dall'indennità di assistenza IPG? Il **contributo per l'assistenza AI** (CHF 35.30/ora base, CHF 52.95/ora con qualifiche) è versato a persone invalide per pagare un assistente esterno (non un familiare stretto) che le accudisce a domicilio. Serve per evitare il ricovero in istituto, che costerebbe di più. L'**indennità di assistenza IPG** è invece una misura diversa: spetta ai genitori che devono assentarsi dal lavoro per accudire un figlio minorenne con gravi problemi di salute, per un massimo di **98 giorni** nell'arco di 18 mesi. **I due strumenti non vanno mai confusi.**

Chi sono i familiari curanti e quali rischi corrono (caregiver burden)? Il **familiare curante** è chi presta regolarmente assistenza non professionale a una **persona dipendente da terzi**. In Ticino sono oltre **50.000**, il **55% donne**, il **63% occupati professionalmente**. Si occupano di economia domestica, coordinamento delle cure, questioni amministrative, sorveglianza, aiuto infermieristico. Il rischio principale è il **caregiver burden**: isolamento sociale, ansia, disturbi del sonno, stanchezza fisica e psichica. Il sistema prevede strumenti di sostegno: congedo di assistenza (max 10 giorni/anno), accrediti assistenziali per la futura rendita AVS, rete di servizi SADC, centri diurni, soggiorni di sollievo.

Perché l'assistenza sociale non è un'assicurazione sociale e come si distingue? **L'assistenza sociale è una prestazione commisurata al bisogno, non un'assicurazione sociale.** Non è finanziata da contributi prelevati sul salario ma da fondi cantonali (imposte). Non si basa sul principio assicurativo — non occorre aver versato contributi per accedervi — ma sulla prova dei mezzi: si riceve solo se reddito e patrimonio sono insufficienti a coprire il minimo vitale. **È l'ultima rete di sicurezza del sistema, interviene in modo sussidiario dopo tutte le assicurazioni sociali.**

Concetti chiave

Termine	Significato
AI	Assicurazione Invalidità — copre tutta la popolazione residente
LAI	Legge federale sull'assicurazione invalidità
LISPI	Legge cantonale ticinese per integrazione invalidi
Rilevamento tempestivo	Identificazione precoce di problemi di salute sul lavoro (entro 30 gg)
Intervento tempestivo	Fase di misure pratiche (max 12 mesi, max CHF 20'000)
Grado di invalidità	Percentuale calcolata economicamente (confronto redditi)
Rendita straordinaria	Per invalidi precoci (< 23 anni) senza 3 anni di contributi → CHF 1'680
Contributo per l'assistenza	Pagamento orario per assistente esterno (CHF 35.30/h base)
Caregiver burden	Sovraccarico fisico/emotivo del familiare curante
AGI	Assegno per grandi invalidi — per chi necessita costante aiuto di terzi
Indennità di assistenza (IPG)	Per genitori con figlio minorenni gravemente malato (max 98 gg)
Sistema meritocratico-occupazionale	Il reddito precedente determina l'entità della rendita

Collegamenti

- **Sessioni 01–05:** sistema dei tre pilastri, AVS, fonti di finanziamento delle assicurazioni sociali
- **Modulo disabilità:** LISPI, strutture LISPI, integrazione invalidi
- **Tema aperto d'esame:** Spiega cos'è l'AI, cosa fa, e perché il grado di invalidità è una definizione economica e non medica
- **Domanda pratica (da slide):** una persona in malattia da 3 mesi riceve un modulo dall'Ufficio AI e non capisce. Come glielo spieghi da operatore sociale?